Pharmacie du Val

200 avenue de la Division Leclerc

95200 Sarcelles

MEMOIRE DEUST 2

SUIVI AU COMPTOIR D'UNE PATIENTE ATTEINTE DE DREPANOCYTOSE

Présenté par : Myriam ROCHDI

Tuteur pédagogique : Hélène HEDDE

Tuteur entreprise : Mohammed HAMZAOUI

Année universitaire 2025-2026

Je souhaite exprimer toute ma gratitude envers l'ensemble de mes professeurs, et plus particulièrement Madame HEDDE, pour son encadrement, ses conseils précieux et sa bienveillance tout au long de ce projet.

Je tiens également à remercier sincèrement mon ancien titulaire, M. HAMADOU, ainsi que mon pharmacien titulaire actuel, M. HAMZAOUI, pour leur confiance et leur pédagogie. Leur soutien constant m'a permis de mieux comprendre les enjeux du métier et de progresser chaque jour.

Un grand merci également à mes collègues, qui, par leur patience et leur disponibilité, ont toujours été là pour répondre à mes nombreuses interrogations, et qui ont su créer un environnement de travail agréable et stimulant.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la patiente pour sa précieuse coopération et sa bienveillance, qui ont été essentielles à l'élaboration de ce cas clinique.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ma réussite et m'ont permis de grandir, tant sur le plan professionnel que personnel.

Introduction 3
PARTIE 1 : Présentation du cas clinique et analyse de l'ordonnance 4
1.1 Présentation du dossier de la patiente 4
1.2 Présentation de l'ordonnance 5
1.3 Analyse pharmacologique de l'ordonnance 5
PARTIE 2 : La drépanocytose et sa prise en charge thérapeutique 9
2.1 Physiopathologie de la drépanocytose 9
2.2 Manifestations cliniques et complications 9
2.3 Prise en charge thérapeutique de la drépanocytose 10
PARTIE 3 : Dispensation officinale et accompagnement de la patiente 12
3.1 Plan de prise et observance 12
3.2 Effets indésirables et surveillance biologique 12
3.3 Conseils officinaux et prévention des crises 13
3.4 Rôle de l'équipe officinale 14
Conclusion 15
Annexes 16
Lexique 19
Bibliographie 19
Résumé 21
Mots clés 21

Introduction

La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente en France et dans le monde, touchant environ 7,7 millions de personnes à l'échelle globale en 2021 selon l'OMS. Cette pathologie de l'hémoglobine est caractérisée par une déformation des hématies en forme de faucille, provoquant une obstruction de la microcirculation. Ce phénomène est à l'origine de crises vaso-occlusives intenses et de complications organiques graves qui réduisent l'espérance de vie, rendant un suivi médical et thérapeutique rigoureux indispensable. Si elle concerne principalement les populations d'origine africaine, antillaise et indienne, son incidence en France métropolitaine est particulièrement marquée en Île-de-France, où l'on dénombre un nouveau-né atteint pour 674 naissances dépistées.

Dans ce contexte de chronicité, l'équipe officinale occupe une place stratégique. Au-delà de la dispensation, nous assurons l'éducation thérapeutique, la surveillance de l'observance et le conseil en hygiène de vie, des leviers essentiels pour améliorer la qualité de vie des patients. C'est dans le cadre de mon activité professionnelle que j'ai accompagné une patiente de 23 ans, atteinte de drépanocytose.

L'objectif de ce mémoire est d'analyser la prise en charge thérapeutique de cette patiente à travers l'étude de son ordonnance, afin de mettre en lumière les conseils officinaux permettant d'optimiser le bon usage des médicaments. Ce travail s'articulera en trois temps : nous présenterons d'abord le cas clinique et l'analyse de l'ordonnance; nous aborderons ensuite la pathologie et ses stratégies thérapeutiques; enfin, nous détaillerons la dispensation officinale et l'accompagnement spécifique nécessaire à la gestion quotidienne de la maladie.

PARTIE 1 : Présentation du cas clinique et analyse de l'ordonnance

1.1 Présentation du dossier de la patiente

Le cas clinique étudié concerne une patiente de 23 ans, née à Paris d'origine malienne, atteinte de drépanocytose homozygote SS diagnostiquée dès la naissance par le test de Guthrie. Sa pathologie est caractérisée par une anémie hémolytique chronique, des phénomènes vaso-occlusifs touchant principalement ses articulations et une vulnérabilité accrue aux infections. Cette condition a lourdement impacté son parcours, entraînant une déscolarisation universitaire malgré la mise en place d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Actuellement sans activité professionnelle, elle subit des douleurs suffisamment invalidantes pour limiter ses sorties environ six fois par mois.

Son suivi médical est coordonné par un spécialiste en médecine interne et comprend deux consultations annuelles accompagnées de bilans biologiques. Ce suivi est complété par une surveillance radiologique annuelle d'un anévrisme cérébral stable, découvert en 2023 et non traité en raison de sa petite taille.

La prévention occupe une place centrale dans sa prise en charge, reposant notamment sur une couverture vaccinale rigoureuse ainsi que sur des mesures hygiéno-diététiques strictes, telles qu'une hydratation abondante et l'éviction du froid.

En cas de crise, la patiente suit un protocole antalgique progressif débutant par le Paracétamol, puis le Tramadol, avant d'envisager un recours aux urgences. Dans la majorité des cas, une consultation aux urgences n'est pas nécessaire. Un cercle vicieux s'est mis en place depuis son entrée à l'université, le stress lié à la crainte de manquer les cours en raison d'une crise constitue lui-même un facteur déclenchant de nouvelles crises vaso-occlusives douloureuses. Par conséquent la fréquence des crises vaso-occlusives s'est intensifiée, passant de deux à trois hospitalisations par an, chacune d'une durée moyenne d'une semaine.

Sur le plan thérapeutique, la patiente est traitée par Hydroxycarbamide. Bien que ce traitement vise à réduire la récurrence des crises, il lui cause de nombreuses nausées matinales. Elle a également été mise en garde contre l'usage des corticoïdes, susceptibles de favoriser les crises vaso-occlusives. Enfin, l'impact psychosocial de la maladie reste majeur, engendrant un isolement social et une fragilité émotionnelle,

bien que la patiente maintienne un lien avec la communauté drépanocytaire via les réseaux sociaux pour s'informer.

1.2 Présentation de l'ordonnance

L'ordonnance analysée (cf. annexe 1) est une prescription bi-zone établie dans le cadre d'une Affection de Longue Durée (ALD), précisément l'ALD n° 10 correspondant aux syndromes drépanocytaires majeurs de l'adulte selon la Haute Autorité de Santé (HAS). Il s'agit d'une prescription hospitalière rédigée par un praticien hospitalier spécialisé en médecine interne pour un traitement renouvelé régulièrement. Pour le Tramadol, la réglementation impose l'utilisation d'une ordonnance sécurisée (cf. annexe 2) afin d'encadrer la délivrance de cet antalgique depuis le 1er mars 2025. De plus, le Tramadol ne peut être prescrit que pour une durée maximale de 3 mois, une nouvelle ordonnance sécurisée est nécessaire pour une prescription plus longue.

La stratégie thérapeutique repose sur deux axes principaux : le traitement de fond et la gestion de la douleur. Le traitement de fond comprend l'acide folique (Spéciafoldine 5 mg), utilisé pour la prévention de l'anémie liée à l'hémolyse chronique, et l'Hydroxycarbamide (Hydrea 500 mg), qui vise à réduire la fréquence des crises vaso-occlusives. Une supplémentation en vitamine D (Uvedose 50 000 UI) complète ce dispositif.

Le traitement des douleurs, liées au phénomène vaso-occlusif, suit une stratégie par paliers. Le paracétamol (Doliprane 1000 mg) est un antalgique de palier I. En cas de douleur non soulagée par le paracétamol, le tramadol 50 mg, antalgique de palier II, est utilisé.

1.3 Analyse pharmacologique de l'ordonnance

L'Hydroxycarbamide, ou Hydroxyurée (Hydrea 500 mg), est un médicament antinéoplasique cytostatique. Son mécanisme exact n'est pas totalement élucidé, mais son action principale cible la moelle osseuse, entraînant une augmentation de l'hémoglobine fœtale (HbF), ce qui limite la falciformation des globules rouges et

diminue la fréquence des crises vaso-occlusives, bien que cet usage soit hors autorisation de mise sur le marché (AMM).

L'Hydrea est officiellement indiquée dans certaines leucémies, la polyglobulie primitive et la thrombocytémie essentielle à haut risque de thrombose. Dans ce cas clinique, la posologie est de 1000 mg en une seule prise le soir. Elle impose une surveillance stricte, incluant la numération de formule sanguine (NFS), ainsi que le contrôle de la fonction rénale et hépatique. Les effets indésirables incluent : myélosuppression, troubles digestifs (nausées, aphtes), troubles cutanés (ulcères, hyperpigmentation), fatigue et fièvre. L'hydroxycarbamide est contre-indiquée avec la grossesse, l'allaitement et le vaccin contre la fièvre jaune. Il est déconseillé avec les vaccins vivants atténués. En raison de sa génotoxicité, une contraception efficace est obligatoire pendant le traitement et six mois après l'arrêt.

L'Acide folique (Spéciafoldine 5 mg) aussi appelé vitamine B9 appartient à la classe des préparations anti-anémique. La vitamine B9 est essentielle à la formation des hématies. Elle est indiquée pour traiter les anémies macrocytaires par carence, les troubles d'absorption intestinale, ou, dans le cadre obstétrical, en cas de déficit prouvé. Ici, l'indication est la prévention de l'anémie liée à l'hémolyse chronique. Dans le cas de la drépanocytose, la durée de vie des hématies falciformes est réduite, ce qui justifie cet apport. La posologie est d'un comprimé de 5 mg par jour, pris le soir. La tolérance est généralement bonne, mais une surveillance biologique peut être effectuée pour contrôler l'efficacité et les interactions possibles, notamment avec certains anticonvulsivants.

Le Cholécalciférol (Uvedose 50 000 UI) aussi appelé vitamine D3, appartient à la classe pharmacologique des vitamines D et analogues. Son mécanisme d'action consiste à stimuler l'absorption intestinale du calcium et son incorporation dans le tissu ostéoïde. Dans le rein, il réduit l'excrétion du calcium et du phosphate en augmentant la résorption tubulaire. Ce médicament est indiqué pour le traitement du déficit en vitamine D, ou pour la prévention chez les patients à haut risque de carence. Il est également utilisé en appoint d'un traitement contre l'ostéoporose en cas de risque d'insuffisance vitaminique. Dans notre cas l'indication est le traitement du déficit en vitamine D, avec une posologie d'une capsule de 50 000 UI par mois. Une surveillance

biologique du calcium et du phosphate est recommandée pour éviter l'hypercalcémie.

Le Paracétamol (Doliprane 1000 mg) est un antalgique de palier I et antipyrétique, d'action centrale et périphérique. Indiqué pour la prise en charge symptomatique des douleurs légères à modérées et de la fièvre. Ici il est prescrit pour soulager les douleurs de faible intensité des crises vaso-occlusives, avec une posologie d'1 g par prise, sans dépasser 3 g par jour. L'effet indésirable principal est la toxicité hépatique en cas de surdosage.

Le Tramadol 50 mg est un antalgique opioïde de palier II, d'action centrale, indiqué pour les douleurs modérées à intenses lorsque le paracétamol est insuffisant. La posologie est d'une gélule trois fois par jour si nécessaire. Parmi les effets indésirables très fréquents, on note des vertiges et des nausées. D'autres effets fréquents incluent des céphalées, une somnolence, une constipation, une sécheresse buccale, des vomissements, une hyperhidrose et une asthénie. Il faut être vigilant aux interactions avec les autres dépresseurs du système nerveux central. La consommation d'alcool est déconseillée durant le traitement, et il ne peut être pris en cas de grossesse.

On retrouve sur cette ordonnance une association bénéfique entre le traitement de fond (Hydroxycarbamide et acide folique) et le traitement de crise (paracétamol et Tramadol), permettant de diminuer la fréquence des crises vaso-occlusives et de traiter les douleurs lorsqu'elles surviennent. Aucune interaction médicamenteuse majeure n'est observée entre ces traitements.

DCI (Princeps) et posologie	**Classe pharmacothérapeutique**	**Indication thérapeutique**	**Effets indésirables**
Hydroxycarbamide (Hydrea 500 mg) 2 gélules le soir	Antinéoplasique cytostatique.	Traitement de fond : Réduire la fréquence des crises vaso-occlusives en	- Myélosuppression - troubles digestifs - alopécie - anorexie - fatigue - troubles cutanés

		augmentant l'hémoglobine fœtale (HbF).	
Acide folique (Spéciafoldine 5 mg) 1 comprimé le soir.	Préparation anti-anémique (Vitamine B9).	Traitement de fond : Prévention de l'anémie liée à l'hémolyse chronique	- Réactions allergiques cutanées (rare)
Cholécalciférol (Uvedose 50 000 UI) 1 capsule par mois.	Vitamine D3 et analogues.	Traitement du déficit en vitamine D.	-Hypercalcémie en cas de surdosage
Paracétamol (Doliprane 1000 mg) 1g par prise si douleurs (max 3g/jour).	Antalgique de palier I et antipyrétique.	Traitement de crise : Gestion symptomatique des douleurs de faible intensité.	-Toxicité hépatique en cas de surdosage
Tramadol 50 mg 1 gélule 3 fois par jour si douleurs non soulagées par le paracétamol.	Antalgique opioïde de palier II.	Traitement de crise : Contrôle antalgique puissant pour les douleurs modérées à intenses.	- Nausées - Vertiges - Somnolence - Constipation - Sécheresse buccale - Asthénie

PARTIE 2 : La drépanocytose et sa prise en charge thérapeutique

2.1 Physiopathologie de la drépanocytose

La drépanocytose, également appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire de transmission autosomique récessive appartenant au groupe des hémoglobinopathies. Elle résulte d'une anomalie structurale de l'hémoglobine. Plusieurs formes génétiques existent, mais la forme homozygote SS constitue la forme la plus sévère et se caractérise par la présence quasi exclusive d'hémoglobine S (HbS).

La maladie est due à une mutation du gène codant pour la chaîne β de la globine située sur le chromosome 11. Cette mutation entraîne la formation d'une hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Contrairement à l'hémoglobine A physiologique, l'HbS se polymérise lorsque la pression en oxygène diminue, formant des polymères fibreux intracellulaires responsables de la déformation des érythrocytes en forme de faucille, d'où le terme « S » provenant de l'anglais Sickle.

Cette transformation entraîne une diminution de la déformabilité des globules rouges, qui deviennent plus fragiles et circulent difficilement dans la microcirculation. Bien que les enfants atteints ne présentent généralement pas de signes cliniques à la naissance, la maladie peut être dépistée précocement par l'identification de l'HbS dans le sang, notamment dans le cadre du dépistage néonatal, par le test de Guthrie.

2.2 Manifestations cliniques et complications

La physiopathologie de la drépanocytose repose principalement sur trois mécanismes : l'anémie hémolytique chronique, les phénomènes vaso-occlusifs et la susceptibilité accrue aux infections.

Les hématies falciformes présentent une durée de vie réduite, de 10 à 20 jours contre environ 120 jours pour une hématie normale, entraînant une anémie hémolytique chronique liée à leur destruction prématurée. Par ailleurs, leur rigidité et leur adhérence favorisent l'obstruction des capillaires, provoquant des crises vaso-occlusives

responsables d'ischémie tissulaire et de douleurs aiguës intenses pouvant toucher les os, les articulations, l'abdomen ou le thorax.

La répétition de ces phénomènes altère progressivement la fonction splénique et conduit à une asplénie fonctionnelle, exposant les patients à un risque accru d'infections sévères, notamment par des bactéries encapsulées.

La drépanocytose peut également entraîner des complications systémiques touchant plusieurs organes. Parmi les plus graves figurent le syndrome thoracique aigu, cause majeure de mortalité, les complications neurologiques telles que les accidents vasculaires cérébraux, ainsi que les atteintes rénales pouvant évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Des complications osseuses, notamment l'ostéonécrose aseptique ou les ostéomyélites, peuvent également être observées.

Au-delà des complications médicales, la maladie a un impact important sur la qualité de vie des patients. Les douleurs chroniques, la fatigue liée à l'anémie et les hospitalisations répétées peuvent entraîner un retentissement psychosocial significatif, affectant la scolarité, la vie professionnelle et les relations sociales.

2.3 Prise en charge thérapeutique de la drépanocytose

La prise en charge de la drépanocytose repose sur une approche globale visant à réduire la fréquence des crises vaso-occlusives, prévenir les complications et améliorer la qualité de vie des patients.

Le traitement de fond repose notamment sur l'Hydroxycarbamide, présent dans les spécialités Hydrea et Siklos. Cette molécule stimule la production d'hémoglobine fœtale (HbF), ce qui limite la polymérisation de l'hémoglobine S et réduit la falciformation des érythrocytes. Ce traitement permet ainsi de diminuer la fréquence des crises douloureuses et des hospitalisations. En raison du risque de myélosuppression, une surveillance biologique régulière par numération formule sanguine est nécessaire. Une supplémentation en acide folique est également souvent prescrite afin de soutenir l'érythropoïèse stimulée par l'hémolyse chronique.

La prise en charge des crises vaso-occlusives repose sur un traitement antalgique adapté, débutant généralement par des antalgiques de palier I tels que le paracétamol,

puis par des opioïdes en cas de douleurs plus intenses. Une hydratation suffisante est également recommandée afin de réduire la viscosité sanguine. Dans les situations les plus sévères, une hospitalisation peut être nécessaire pour une analgésie renforcée et une réhydratation intraveineuse.

D'autres stratégies thérapeutiques peuvent être utilisées selon les situations, notamment les transfusions sanguines visant à réduire la proportion d'hémoglobine S circulante, en particulier pour prévenir certaines complications neurologiques.

Enfin, la prévention des infections et le suivi médical régulier constituent des éléments essentiels de la prise en charge. Ils reposent sur le respect du calendrier vaccinal et sur un suivi spécialisé associant examens biologiques et imagerie afin de dépister précocement les complications.

PARTIE 3 : Dispensation officinale et accompagnement de la patiente

3.1 Plan de prise et observance

L'observance thérapeutique constitue un facteur déterminant dans la prise en charge de la drépanocytose. Une mauvaise adhésion au traitement de fond peut diminuer son efficacité et favoriser la survenue de crises vaso-occlusives.

Au cours de l'adolescence, la patiente a présenté des difficultés d'observance, notamment lors de périodes de déprime liées à l'impact psychologique de la maladie. Afin d'améliorer l'adhésion thérapeutique, un pilulier hebdomadaire préparé à l'officine a été mis en place dès l'âge de douze ans à la demande du médecin spécialiste. Ce dispositif facilite l'organisation du traitement et limite les oublis. Le traitement de fond est pris le soir afin de simplifier la prise.

Lors de chaque délivrance, l'équipe officinale vérifie la bonne compréhension des prescriptions et rappelle l'importance de la régularité du traitement.

3.2 Effets indésirables et surveillance biologique

Le suivi pharmacologique repose principalement sur la surveillance du traitement par Hydroxycarbamide. Ce médicament peut entraîner une myélosuppression se traduisant par une leucopénie, une thrombopénie ou une anémie. Un suivi biologique régulier par NFS est donc nécessaire afin de détecter précocement toute anomalie. La patiente réalise une NFS avant ses consultations semestrielles avec le médecin spécialiste et ponctuellement en cas d'infection.

La patiente souffre de plusieurs effets indésirables liés à l'Hydroxycarbamide, tels que des nausées, de la fatigue, de l'alopécie et une anorexie avec un indice de masse corporelle (IMC) de 18, correspondant à une insuffisance pondérale, ce qui nécessite une vigilance particulière sur le plan nutritionnel. Les nausées matinales rapportées par la patiente ont conduit au conseil officinal d'une prise de Métopimazine si nécessaire. L'Hydroxycarbamide étant génotoxique, une contraception efficace est recommandée pendant le traitement et jusqu'à six mois après son arrêt.

Concernant la prise en charge des douleurs, le respect des doses maximales de paracétamol doit être rappelé afin de prévenir le risque d'hépatotoxicité (1 g par prise,

4 g par 24 heures). Le Tramadol, utilisé en cas de douleurs plus intenses, peut provoquer des effets indésirables fréquents tels que des nausées, des vertiges, une somnolence ou une asthénie.

3.3 Conseils officinaux et prévention des crises

La prévention des crises vaso-occlusives repose en partie sur des mesures hygiéno-diététiques visant à limiter les facteurs favorisant la falciformation des globules rouges. Une hydratation suffisante est essentielle afin de réduire la viscosité sanguine, notamment lors d'efforts physiques, de fortes chaleurs ou de voyages prolongés. L'exposition au froid constitue également un facteur déclenchant potentiel, car elle entraîne une vasoconstriction périphérique pouvant favoriser les phénomènes vaso-occlusifs. Il est donc conseillé de bien se protéger durant les périodes hivernales. La pratique d'une activité physique modérée peut être bénéfique, à condition de maintenir une hydratation suffisante et d'éviter les environnements froids. La patiente a été encouragée à reprendre progressivement une activité adaptée, comme la marche. La gestion du stress et de la fatigue constitue également un élément important de prévention. Le stress étant un problème majeur chez notre patiente nous lui avons conseillé de consulter un psychologue spécialisé en gestion du stress et de l'anxiété, ainsi que des produits de phytothérapie. La prévention des infections repose notamment sur le respect du calendrier vaccinal. La patiente réalise chaque année la vaccination contre la grippe et devra effectuer un rappel vaccinal à l'âge de 25 ans contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche.

Il est essentiel d'informer les patients atteints de drépanocytose des risques liés à l'utilisation des corticoïdes. À cette fin, une infographie destinée aux patients a été réalisée (cf. annexe 3) et accompagnée d'explications orales. Les corticoïdes doivent être utilisés avec prudence chez ces patients, car ils peuvent favoriser la survenue de crises vaso-occlusives sévères. Plusieurs mécanismes physiopathologiques peuvent expliquer ce phénomène : un effet rebond inflammatoire lors de l'arrêt du traitement, associé à une hyperleucocytose favorisant l'obstruction microvasculaire ; une augmentation de l'adhérence des hématies falciformes à l'endothélium vasculaire ; ainsi qu'une augmentation de la viscosité sanguine liée à la rétention hydrosodée et à la stimulation de certaines lignées cellulaires sanguines. Or, ces médicaments sont

fréquemment prescrits dans de nombreuses situations cliniques courantes (pathologies inflammatoires, respiratoires, allergiques ou rhumatologiques). L'éducation thérapeutique est donc essentielle afin d'inciter les patients à signaler systématiquement leur pathologie aux professionnels de santé avant toute prescription, afin de limiter le risque de complications.

3.4 Rôle de l'équipe officinale

En tant que professionnel de santé de proximité, l'équipe officinale joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des patients atteints de drépanocytose. Elle participe à l'éducation thérapeutique, veille à la sécurisation de la dispensation et à la prévention des interactions médicamenteuses. Lors de la délivrance des traitements, elle peut également identifier certains facteurs déclenchants de crises et adapter les conseils délivrés.

Conclusion

La drépanocytose est une pathologie génétique chronique nécessitant une prise en charge médicale rigoureuse et multidisciplinaire. L'étude de l'ordonnance de cette patiente de 23 ans met en évidence l'association d'un traitement de fond, visant à diminuer la fréquence des crises vaso-occlusives, ainsi que d'un traitement antalgique permettant la prise en charge des douleurs liées aux crises.

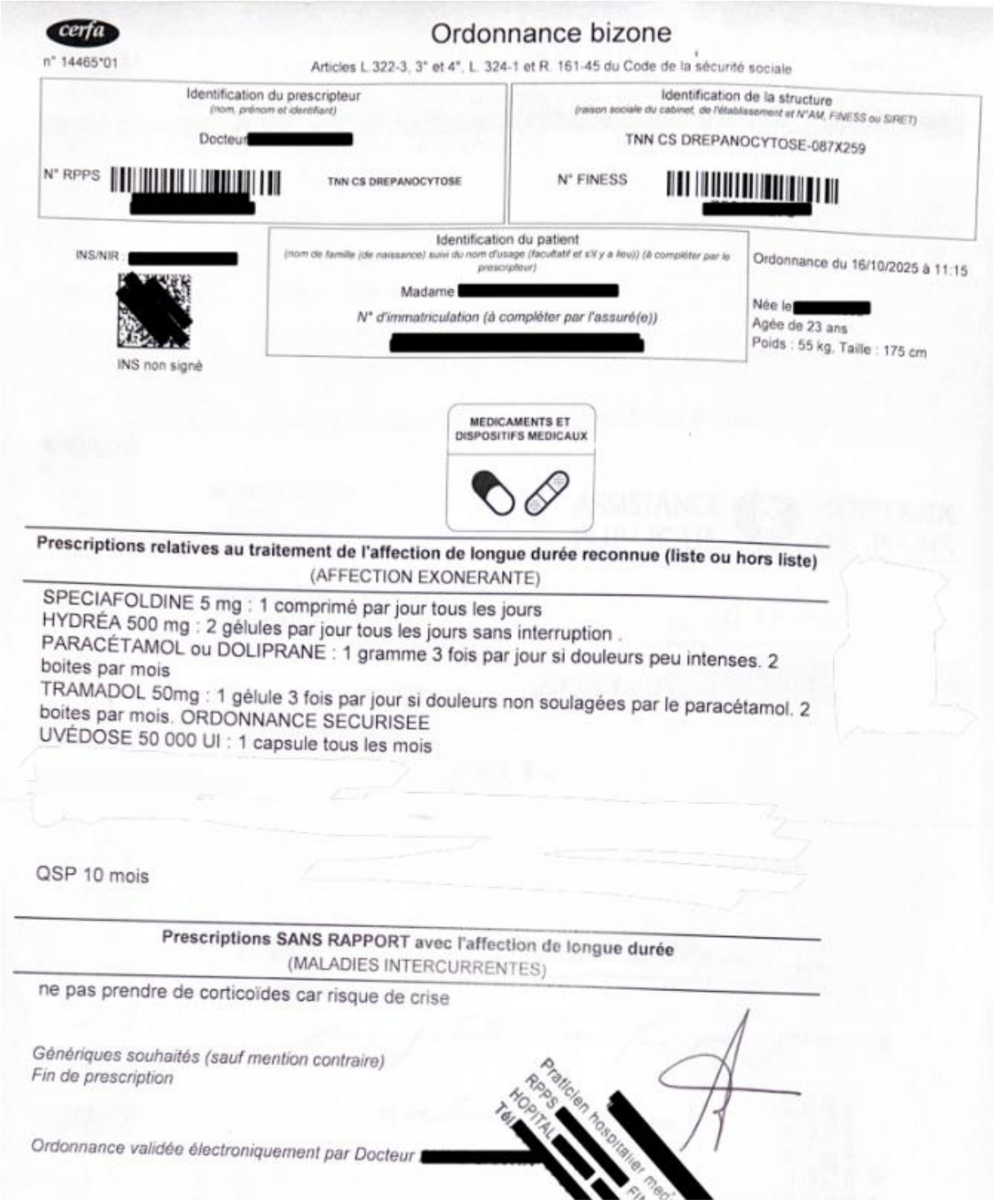
Dans ce contexte, le rôle de l'équipe officinale est essentiel. La dispensation des médicaments ne se limite pas à la délivrance de l'ordonnance : elle s'accompagne également de conseils sur l'observance du traitement, la gestion de la douleur, la prévention des facteurs déclenchants des crises et la surveillance des effets indésirables. Par sa proximité avec les patients, l'officine constitue un lieu privilégié d'écoute, d'information et d'accompagnement dans le suivi des pathologies chroniques.

La prévention occupe également une place importante dans la lutte contre cette maladie. Le dépistage néonatal permet aujourd'hui d'identifier précocement les enfants atteints et d'instaurer rapidement une prise en charge adaptée afin de réduire la morbi-mortalité associée à la drépanocytose. Par ailleurs, un dépistage génétique peut être proposé aux couples souhaitant concevoir un enfant afin de déterminer s'ils sont porteurs du gène de l'hémoglobine S. Lorsque les deux partenaires sont porteurs, un conseil génétique peut être réalisé afin d'évaluer le risque de transmission de la maladie à leur descendance.

Enfin, les progrès récents de la recherche médicale, notamment dans le domaine de la greffe de cellules souches hématopoïétiques et des thérapies géniques, ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients atteints de drépanocytose. Ces avancées laissent entrevoir à long terme des stratégies de prise en charge plus efficaces et potentiellement curatives pour cette maladie encore largement répandue dans le monde.

Annexes

Annexe 1 : Ordonnance



cerfa

n° 14465*01

Ordonnance bizone

Articles L.322-3, 3° et 4°, L. 324-1 et R. 161-45 du Code de la sécurité sociale

Identification du prescripteur
(nom, prénom et identifiant)

Docteur [redacted]

N° RPPS [redacted]

TNN CS DREPANOCYTOSE

Identification de la structure
(raison sociale du cabinet, de l'établissement et N°AM, FINESS ou SIRET)

TNN CS DREPANOCYTOSE-087X259

N° FINESS [redacted]

INS/NIR [redacted]

INS non signé

Identification du patient
(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu)) (à compléter par le prescripteur)

Madame [redacted]

N° d'immatriculation (à compléter par l'assuré(e))

[redacted]

Ordonnance du 16/10/2025 à 11:15

Née le [redacted]
Agée de 23 ans
Poids : 55 kg, Taille : 175 cm

MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)

SPECIAFOLDINE 5 mg : 1 comprimé par jour tous les jours
HYDRÉA 500 mg : 2 gélules par jour tous les jours sans interruption .
PARACÉTAMOL ou DOLIPRANE : 1 gramme 3 fois par jour si douleurs peu intenses. 2 boites par mois
TRAMADOL 50mg : 1 gélule 3 fois par jour si douleurs non soulagées par le paracétamol. 2 boites par mois. ORDONNANCE SECURISEE
UVÉDOSE 50 000 UI : 1 capsule tous les mois

QSP 10 mois

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

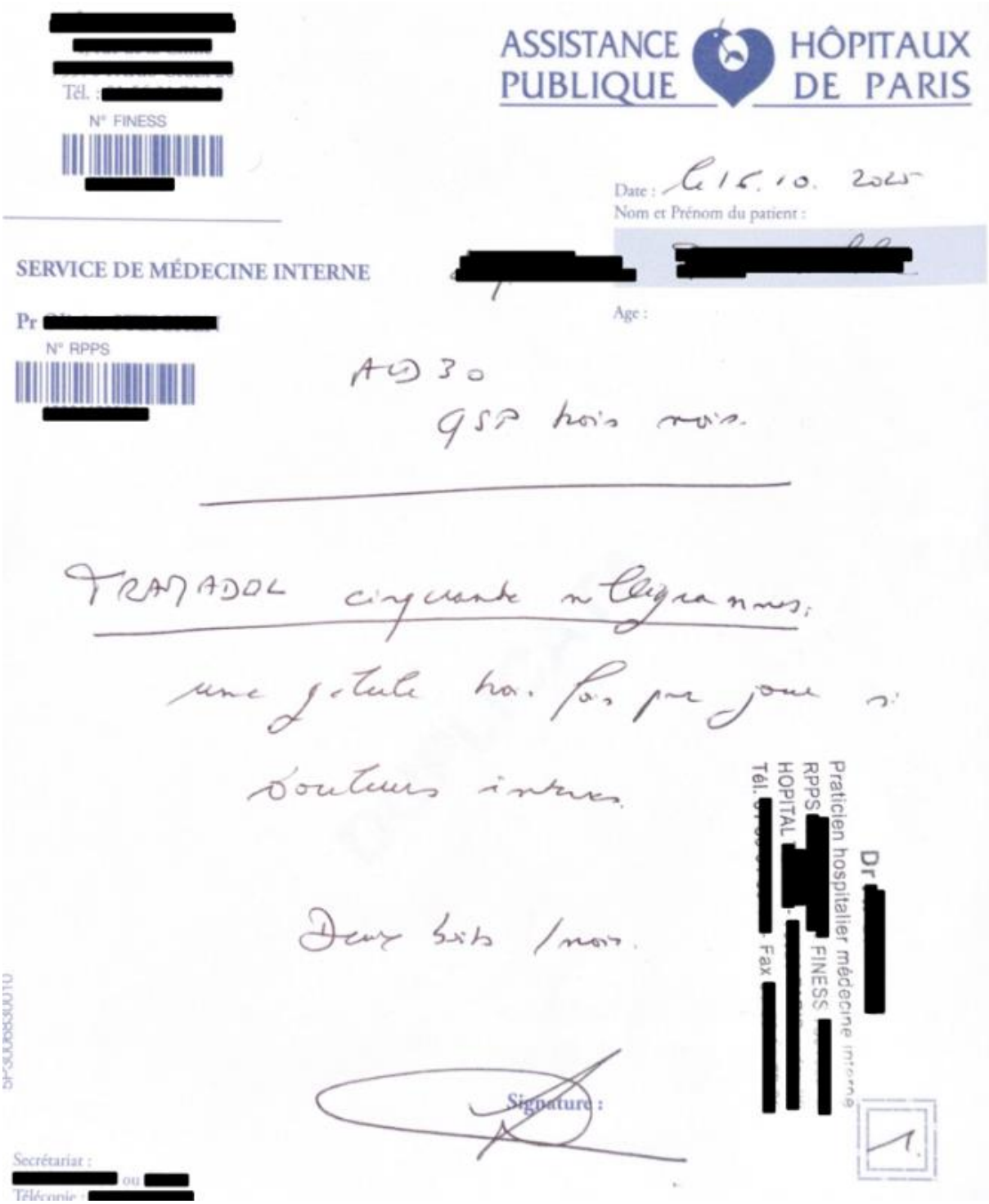
ne pas prendre de corticoïdes car risque de crise

Génériques souhaités (sauf mention contraire)
Fin de prescription

Ordonnance validée électroniquement par Docteur [redacted]

Praticien hospitalier méd[redacted]
RPPS [redacted]
HOPITAL [redacted]
Tél [redacted]
Fi[redacted]

Annexe 2 : Ordonnance sécurisée



[redacted]

Tél. : [redacted]

N° FINESS

[redacted]

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Date : le 16.10. 2025

Nom et Prénom du patient :

[redacted]

SERVICE DE MÉDECINE INTERNE

[redacted]

Pr [redacted]

N° RPPS

[redacted]

Age :

AD 30

QSP trois mois.

TRAMADOL cinquante milligrammes :

une gélule trois fois par jour si

douleurs intenses.

Deux fois / mois.

Dr [redacted]

Praticien hospitalier médecine interne

RPPS [redacted]

FINESS [redacted]

HOPITAL [redacted]

Tél. [redacted] Fax [redacted]

Signature :

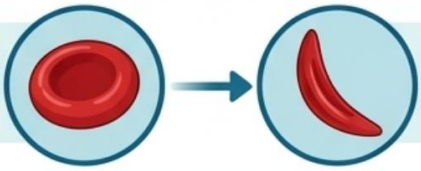
Secrétariat : [redacted] ou [redacted]

Téléconsult : [redacted]

Annexe 3 : Fiche conseils sur les corticoïdes (réalisé sur Canva.com)

DRÉPANOCYTOSE & CORTICOÏDES : UN DANGER À CONNAÎTRE

GLOBULE ROUGE NORMAL (rond, souple)



GLOBULE ROUGE DRÉPANOCYTAIRE (faucille, rigide)

POURQUOI LES CORTICOÏDES PROVOQUENT UNE CVO ?
(CRISE VASO-OCCLUSIVE)

1 L'EFFET "REBOND" À L'ARRÊT

Le nombre de **globules blancs explose.** Ils deviennent "collants" et bouchent les vaisseaux.

2 SANG PLUS "COLLANT"

Augmentation des molécules d'adhérence.

3 SANG PLUS "ÉPAIS" (Viscosité)

Augmentation du nombre de cellules.

RÉSULTAT : CVO GRAVES

RECONNAÎTRE LES MÉDICAMENTS
(DCI & Noms Commerciaux)

DCI (Dénomination Commune Internationale)	**Noms Commerciaux** (Princeps)
Prednisolone	**SOLUPRED**, Mégapred
Prednisone	**CORTANCYL**
Méthylprednisolone	**MEDROL**, Solu-Medrol
Bétaméthasone	**CELESTÈNE**, Betnesol
Dexaméthasone	**DECTANCYL**, Neofordex
Triamcinolone	**KENACORT**, Ledercort
Hydrocortisone	**Hydrocortisone Roussel**

SITUATIONS À RISQUE DE PRESCRIPTION REFLEXE

Mal de dos aigu (Sciatique, Lumbago)
Réduire l'inflammation
RISQUE DE CVO

Asthme sévère ou Bronchite sévère
Ouvrir les bronches
RISQUE DE CVO

Laryngite aiguë (Enfant)
Dégonfler la gorge
RISQUE DE CVO

Réaction allergique forte (Urticaire géant)
Stopper la réaction
RISQUE DE CVO

Douleurs articulaires aiguës (Goutte, Arthrite)
Calmer la douleur
RISQUE DE CVO

LE RÉFLEXE DE SÉCURITÉ

1. INFORMEZ : "Je suis drépanocytaire. Mon hématologue m'a interdit les corticoïdes (comme le Solupred ou le Celestène)."

2. VÉRIFIEZ : Lisez toujours l'ordonnance.

3. APPELEZ : En cas de doute, contactez votre centre de référence drépanocytose avant de prendre le médicament.

Lexique

PAI : Projet d'Accueil Individualisé

ALD : Affection de Longue Durée

HbF: hémoglobine fœtale

HbS : hémoglobine S

AMM : autorisation de mise sur le marché

HAS : Haute Autorité de Santé

IMC : Indice de masse corporelle

Bibliographie

- Rédaction OMS: Drépanocytose, 2025, consulté le 01/03/26 : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/sickle-cell-disease
- Rédaction HAS : ALD n° 10 - Syndromes drépanocytaires majeurs de l'adulte, 2010, consulté le 08/03/26 : https://www.has-sante.fr/jcms/c_938884/fr/ald-n-10-syndromes-drepanocytaires-majeurs-de-l-adulte
- Rédaction VIDAL : Drépanocytose de l'enfant, 2025, consulté le 08/03/26 : https://www.vidal.fr/maladies/recommandations/drepanocytose-de-l-enfant-4032.html#prise-en-charge
- Rédaction VIDAL : Drépanocytose, 2021, consulté le 08/03/26 : https://www.vidal.fr/maladies/coeur-circulation-veines/drepanocytose.html
- Ministère des solidarités et de la santé, Base de données publique des médicaments, Hydrea , 2026, site consulté le 02/03/2026 : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/69700567/extrait#tab-rcp
- Ministère des solidarités et de la santé, Base de données publique des médicaments, Speciafoldine, 2024 , site consulté le 02/03/2026 : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/69630186/

extrait#tab-rcp
- Ministère des solidarités et de la santé, Base de données publique des médicaments, Doliprane, 2025, site consulté le 02/03/2026 : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/60234100/extrait#tab-rcp
- Ministère des solidarités et de la santé, Base de données publique des médicaments, Tramadol , 2025, site consulté le 02/03/2026 : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/62484259/extrait#tab-rcp
- Ministère des solidarités et de la santé, Base de données publique des médicaments, Uvedose 50 000 UI, 2025, site consulté le 02/03/2026 : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/63158750/extrait#tab-rcp

Résumé

La drépanocytose est une hémoglobinopathie génétique responsable d'anomalies de la forme des érythrocytes, entraînant des épisodes vaso-occlusifs douloureux et de multiples complications. Sa prise en charge repose sur un suivi médical régulier, des traitements de fond visant à réduire la fréquence des crises et des mesures préventives destinées à limiter les facteurs déclenchants.

Ce mémoire analyse la prise en charge officinale d'une patiente atteinte de drépanocytose, en mettant en évidence le rôle de l'équipe officinale dans l'accompagnement thérapeutique, la sécurisation de la dispensation et l'éducation du patient. Il aborde également les stratégies thérapeutiques actuelles, notamment l'utilisation de l'hydroxycarbamide, ainsi que les modalités de surveillance et de prévention des complications.

Mots clés

Drépanocytose, Hémoglobine S, Hydroxycarbamide, Acide folique, Crise vaso-occlusive, Dispensation officinale.